Autos: 0800476-28.2024.8.12.0010
Ação: Procedimento Comum Cível - Fornecimento de medicamentos
Autor:Emanoelle Tiemy de Andrade Guimarães
Réu: Estado de Mato Grosso do Sul

SENTENÇA

Emanoelle Tiemy de Andrade Guimarães promove ***"Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência"*** em face do **Estado de Mato Grosso do Sul**, ambos qualificados na inicial (p. 1).

Em síntese, a parte autora argumentou que é portadora de transtornodepressivo recorrente (CID F33.1) e transtorno do pânico (CID F41.0) e, devido às suas enfermidades, foram-lhe receitados os fármacos Revoc 100mg e Desduo 100mg. Tais medicamentos não são disponibilizados pelo SUS gratuitamente à população de Fátima do Sul/MS. Não possui condições financeiras para custear com os gastos com os medicamentos.

Com base nesses fatos, formulou pedido para concessão antecipada da tutela de urgência, com ordem para que o Estado de Mato Grosso do Sul cumpra imediatamente com a obrigação de fornecer o medicamento receitado, sob pena de multa. O pedido final, consiste na confirmação da tutela de urgência. Requereu, também, o benefício da gratuidade. Deu à causa o valor de R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais).

A petição inicial (p. 1/8) veio acompanhada de declaração de pobreza (p. 9) e documentos (p. 10-22).

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) apresentou parecer desfavorável ao pedido (p. 26/35).

Na decisão de p. 36/41, o juízo concedeu assistência judiciária gratuita à autora e deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela.

Em contestação (p. 54/63), o Estado de Mato Grosso do Sul aduziu preliminar de inclusão da União em observância do TEMA 1234 e TEMA 6, ambos do STF. Discorreu sobre os requisitos específicos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS e a inviabilidade de fornecimento da medicação com base no nome comercial. Diante do exposto, requer sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. No caso de procedência, requer: a. promovida a intimação da parte autora para emendar a inicial, a fim de incluir a União no polo passivo da demanda, em observância à decisão proferida no RE 1366243/SC (tema 1234). Quanto ao mérito, pede seja(m) julgado(s) improcedente(s) o(s) pedido(s) de: a. fornecimento de medicamento(s) não incorporado(s) ao SUS, em razão do não preenchimento dos requisitos fixados no tema 106 do STJ. No caso de procedência, requer: a. seja direcionado à UNIÃO o cumprimento da obrigação relativa ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, garantindo-se ao Estado o direito de ressarcimento no caso de custeio com recursos próprios. b. seja estipulada a obrigatoriedade da apresentação de receita médica atualizada para retirada dos medicamentos e que seja autorizado o fornecimento com base no princípio ativo, nos termos do art. 3º, §2º da Lei n. 9.787/99. c. no caso de execução forçada do julgado, não

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 06/06/2025 às 08:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800476-28.2024.8.12.0010 e código XarZ4fG5.

haja fixação de multa diária, dando-se preferência ao bloqueio de verbas, nos termos do enunciado 74 da Jornada de Direito da Saúde. d. em caso de bloqueio de valores para aquisição do medicamento, seja observado o PMVG, devendo a nota fiscal ser emitida em no- me e CNPJ do Estado.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (p. 67).

Alegações finais das partes (p.76/77; p. 81).

Parecer do MPE (p. 86/97).

É o relatório.
Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado, conforme prevê o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo necessidade de dilação probatória.

Nossos Tribunais assim têm se pronunciado a respeito do julgamento antecipado: "*Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder*". (STJ - 4ª Turma - REsp 2.832, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo).

A doutrina da mesma forma assim já se posicionou: "*O juiz deve sempre impedir a realização de provas ou diligências inúteis (art.130). Se o fato foi confessado, se não é controvertido, ou se já está de outro modo provado nos autos, não tem cabimento sobre ele a perícia*" (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, 6ª Edição, Editora Forense, vol. I, p. 475).

Preliminar de inclusão da União:

Defende o Estado de Mato Grosso do Sul a necessidade de inclusão da União do polo passivo da demanda, com consequente remessa do feito para julgamento perante a Justiça Federal.

Sem razão, contudo.

O Supremo Tribunal Federal, a despeito de questionar a concepção de solidariedade sustentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do IAC 14, referendou, em 19/04/2023, decisão liminar proferida no RE 1.366.243 (Tema 1234), para estabelecer os seguintes parâmetros relativos à competência dos entes públicos para figurarem no polo passivo das demandas judiciais na área de saúde:

> *5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;*
>
> ***5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 06/06/2025 às 08:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800476-28.2024.8.12.0010 e código XarZ4fG5.

definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);

Portanto, o Supremo Tribunal Federal, nos autos da Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário 1.366.243-SC, paradigma do Tema 1234, do regime a repercussão geral, limitou a abrangência da Tese fixada no Tema 793.

Nos termos da decisão proferida pelo Relator, Min. Gilmar Mendes, em sede de tutela de urgência, referendada pelo plenário, *"as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo*".

Por fim, em julgamento definitivo do Tema 1234, o STF decidiu que *"(...) as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMCG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC".*

Na hipótese em tela, considerando que o valor anual dos medicamentos não é igual ou superior ao correspondente a 210 salários mínimos, não há falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Ainda que assim o fosse, o Pretório Excelso modulou os efeitos da decisão proferida, determinando que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco.

Logo, uma vez que a presente ação foi ajuizada em março de 2024, antes, portanto, da publicação da aludida decisão (11/10/2024), há de ser mantida a competência da Justiça Estadual para processá-la e julgá-la.

Afasto, portanto, a preliminar arguida.

Mérito:

Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte requerente aduz que é portadora de transtorno depressivo recorrente (CID F33.1) e transtorno do pânico

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 06/06/2025 às 08:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 08000476-28.2024.8.12.0010 e código XarZ4fG5.

(CID F41.0) e, devido às suas enfermidades, foram-lhe receitados os fármacos Revoc 100mg e Desduo 100mg. Tais medicamentos não são disponibilizados pelo SUS gratuitamente à população de Fátima do Sul/MS, bem como não possui condições financeiras para custear com os gastos com os medicamentos.

O pedido esboçado pela parte autora **não merece acolhimento**.

A apreciação do pedido de disponibilização de medicamentos exige cautela, sob pena de imputar consequências irremediáveis ao jurisdicionado e/ou interferir na esfera de competência do Executivo, porquanto, em sendo a saúde um dever, cabe ao Estado implementar políticas sociais e econômicas que visem garantir aos cidadãos, em especial àqueles sem recursos econômicos, o acesso universal e igualitário à assistência médica e farmacêutica.

Inicialmente, anoto que, para concessão de fármacos não disponibilizados pela rede pública de saúde, tampouco padronizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), devem ser integralmente preenchidos os requisitos exigidos nos TEMAS 1234 e 6 do STF, além do TEMA 106 do STJ.

Infere-se que houve a negativa administrativa quanto ao fornecimento dos medicamentos (p. 17/18), bem como que a receita médica foi elaborada por médico particular (p. 13).

Quanto à hipossuficiência econômica da parte autora, tem-se que devidamente demonstrada, pois está sendo assistida pela DPE, de modo que presume-se a hipossuficiência consubstanciado na declaração de p. 9, sobretudo porquanto o requerido não apresentou documentos capazes de afastar a presunção.

Os medicamentos solicitados pela requerente estão devidamente registrados na ANVISA (p. 33, item IV).

Contudo, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) foi desfavorável ao pleito (p. 34, item XI), que:

> **XI - Conclusão favorável ou desfavorável ao pedido.**
> Considerando que a paciente está sendo atendida por médico particular.
> Considerando que Succinato de Desvenlafaxina, Maleato de Fluvoxamina não estão padronizados na RENAME 2022.
> Considerando que a RENAME 2022 tem padronizado no CBAF medicamentos antidepressivos (Amitriptilina, Clomipramina, Nortriptilina, Fluoxetina), anticonvulsivantes (Ácido Valproico, Carbamazepina, Fenitoína, Fenobarbital), ansiolíticos (Clonazepam solução oral, Diazepam).
> Considerando as evidências científicas disponíveis, as informações sobre tratamentos realizados (escitalopram, zolpidem, bupropiona, fluoxetina), as opções de medicamentos oferecidos pelo SUS.
> Em face ao exposto, este Núcleo de Apoio Técnico é desfavorável ao pedido de Succinato de Desvenlafaxina, Maleato de Fluvoxamina.

A seu turno, quanto à *imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS*, observa-se que o laudo médico carreado aos autos (p. 14/16) limita-se a apontar as doenças diagnosticadas na parte requerente e a necessidade dos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 06/06/2025 às 08:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800476-28.2024.8.12.0010 e código XarZ4fG5.

medicamentos receitados, porém não existe um detalhamento técnico do porquê não ser possível a utilização dos medicamentos padronizados na RENAME.

Diante disso, caberia à parte requerente demonstrar o preenchimento do requisito relativo à imprescindibilidade dos fármacos pleiteados, nos termos do decidido no mencionado recurso julgado sob o rito repetitivo. Todavia, apesar dos documentos médicos amealhados com a exordial prescreverem os medicamentos, devidamente registrados na ANVISA, tem-se que não restou comprovada sua indispensabilidade e a ineficácia de outros fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia.

Aliás, no tocante aos medicamentos postulados na inicial, conforme parecer do NAT (p. 33, item III):

> Conforme o estudo **Comparative efficacy and tolerability of antidepressants for major depressive disorder in children and adolescents: a network meta-analysis** (Cipriani A, Zhou X, Del Giovane C, et al. Lancet. 2016 Aug 27;388(10047):881-90). O transtorno depressivo maior é um dos transtornos mentais mais comuns em crianças e adolescentes. No entanto, a utilização de intervenções farmacológicas nesta população e qual medicamento deve ser preferido ainda são questões controversas. Resultados: Consideramos 34 ensaios elegíveis, incluindo 5.260 participantes e 14 tratamentos antidepressivos. A qualidade da evidência foi classificada como muito baixa na maioria das comparações. Em termos de eficácia, apenas a fluoxetina foi estatisticamente significativamente mais eficaz do que o placebo. Em termos de tolerabilidade, a fluoxetina também foi melhor que a duloxetina e a imipramina. Os pacientes que receberam imipramina, venlafaxina e duloxetina tiveram mais interrupções devido a eventos adversos do que aqueles que receberam placebo. Interpretação: Ao considerar o perfil risco-benefício dos antidepressivos no tratamento agudo do transtorno depressivo maior, esses medicamentos não parecem oferecer uma vantagem clara para crianças e adolescentes. A fluoxetina é provavelmente a melhor opção a considerar quando um tratamento farmacológico é indicado.

Verifica-se, assim, que há evidencias científicas que os medicamentos pleiteados não oferecem uma vantagem clara para crianças e adolescentes.

Ademais, a negativa de fornecimento do medicamento está de acordo com os protocolos estabelecidos pelo SUS, sendo decisão técnica e administrativa devidamente fundamentada, não cabendo ao Judiciário sobrepor sua decisão às políticas públicas vigentes, a menos que haja flagrante ilegalidade, o que não foi demonstrado.

Nesse trilhar, considerando que os medicamentos postulados não estão incorporado pelo SUS, e não havendo qualquer indicativo de ilegalidade no ato administrativo de não incorporação, não há falar em obrigação do poder público em fornecer esse medicamento.

Além disso, considerando a ausência de comprovação quanto à essencialidade dos medicamentos prescritos para tratamento da parte autora e quanto ao esgotamento de todas as alternativas medicamentosas oferecidas pelo SUS, as quais podem se mostrar eficazes na contenção das doenças, entendo não ser prudente conceder, no presente momento, a medicação receitada pelo profissional de saúde.

Apesar de o profissional médico indicar, como regra, o melhor tratamento que aprouver ao paciente, utilizando-se de todos os meios ao seu alcance para efetivar o direito à saúde, no caso concreto o médico responsável pelo atendimento

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 06/06/2025 às 08:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 08000476-28.2024.8.12.0010 e código XarZ4fG5.

da autora deixou de fundamentar os motivos pelos quais prescreveu medicamentos diferentes dos ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, deixando de consignar o porquê resta impossibilitada a utilização das demais alternativas fornecidas pelo SUS.

Não obstante o direito à saúde, o tratamento a ser disponibilizado não deve ficar ao livre arbítrio do paciente ou de determinado profissional da área médica, sem que se demonstre que o medicamento pretendido é o único ou o mais apto para a finalidade indicada, especialmente quando o ente público disponibiliza opção terapêutica que alega satisfatória.

Inclusive, em momento algum constou do laudo médico que as demais substâncias receitadas pelo NAT como passíveis de controlar as doenças e ainda não utilizadas pela parte autora são impróprias, inadequadas ou não produzem os efeitos adequados ao tratamento da patologia.

Destarte, não existe qualquer elemento seguro para afirmar que todos os medicamentos indicados foram utilizados pela parte requerente sem a eficácia no tratamento de maneira que possa subsidiar o acolhimento do pedido inicial.

Sobre o tema, o Enunciado n. 16 da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiçam, realizada em 15 de maio de 2014 – São Paulo/SP, preconiza que *"nas demandas que visam ao acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o autor deve apresentar prova da evidência científica e também a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS"*, o que, frise-se, não foi feito no caso em testilha.

Nesse sentido, o direito à saúde, que foi definido pela Constituição da República como um direito fundamental da pessoa humana, deve ser levado à sério, tanto pelo Estado quanto pelos profissionais que atuam no sistema de saúde pública ou privada, cuja atuação deve ser pautada pela medicina baseada em evidências e não mais na medicina baseada na autoridade

Não se pode olvidar, ainda, que demonstrando a autora a necessidade do remédio (fato constitutivo de seu direito) e o réu, a possibilidade de sua substituição por outros (fato modificativo/impeditivo), incumbe à primeira a demonstração da impossibilidade da substituição, o que não ocorreu.

Quanto à idoneidade do posicionamento do NAT, é sabido que tal núcleo de apoio foi criado com a finalidade assessorar o Poder Judiciário Estadual, contribuindo com informações técnicas, nas demandas relativas ao fornecimento de medicamentos, exames, internações e demais tratamentos em face do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo órgão de natureza consultiva.

Portanto, sua função é conferir ao julgador maiores elementos técnicos necessários ao desfecho das lides, sem que o magistrado esteja vinculado aos seus pareceres, os quais são isentos de qualquer parcialidade.

Seguindo tal linha intelectiva, somente devem ser afastadas as orientações do NAT em situações em que resta demonstrada a imprescindibilidade

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 06/06/2025 às 08:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 08000476-28.2024.8.12.0010 e código XarZ4fG5.

justificada para a utilização de medicamentos diversos do protocolo clínico estabelecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, diversamente do que ocorreu no caso em tela.

Nesse aspecto, percebendo-se do conjunto dos autos que os medicamentos objetos do pedido não são de natureza essencial ao caso da parte requerente, tal fato recomenda a manutenção da conclusão negativa do parecer confeccionado pelo NAT.

A respaldar o entendimento de que, para a concessão de medicamentos não padronizados pelo SUS, é necessária a demonstração de que os fármacos fornecidos pelo Poder Público não foram eficazes para o tratamento, tem-se os seguintes julgados:

> *APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA. –* ***RESP. N.º 1.657.159 SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSENTE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO E DA AUSÊNCIA DE INEFICÁCIA DO TRATAMENTO OFERECIDO PELO SUS****. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O juiz é o destinatário das provas, podendo indeferir as provas que reputar desnecessárias para o deslinde da causa, sem que configure cerceamento de defesa. De acordo com a tese fixada no REsp n. 1.657159, "****A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento". Ausente comprovação da imprescindibilidade da medicação reclamada e da ausência de ineficácia do tratamento oferecido pelo SUS.****
> *(****TJMS****. Apelação Cível n. 0803514-50.2018.8.12.0045, Sidrolândia, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 29/03/2021, p: 06/04/2021)*
>
> *APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE URGÊNCIA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA –* ***FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TEMAS 106, DO STJ E 1234, DO STF – LEGALIDADE DO ATO DE NÃO INCORPORAÇÃO E DA NEGATIVA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA, COM FUNDAMENTO NA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS, DA SEGURANÇA E EFICÁCIA DOS FÁRMACOS – LAUDO MÉDICO DESACOMPANHADO DE RESPALDO CIENTÍFICO DE ALTO NÍVEL – SENTENÇA REFORMADA*** *– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não se conhece da remessa necessária quando interposto recurso voluntário pelo órgão da Fazenda Pública, conforme inteligência do art. 496, § 1º, do Código de Processo Civil dada por esta Câmara e tendo em vista o princípio da colegialidade, previsto no art. 926, caput, do CPC, ressalvado o posicionamento deste julgador. Segundo o tema repetitivo n. 106, do Superior Tribunal de Justiça, "a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 06/06/2025 às 08:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800476-28.2024.8.12.0010 e código XarZ4fG5.

*fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." Contudo, após a interposição do recurso de apelação pelo ente municipal (29/02/2024), o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.234 de repercussão geral, em 16 de setembro de 2024, conforme ata publicada no DJE de 19/09/2024, proferiu o julgamento do tema 1234, fixando os seguintes requisitos para o fornecimento de medicamento não incorporado: "[...] 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta análise. [...]" **Na hipótese dos autos, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, na medida que os estudos apresentados pelo NAT não evidenciam a eficácia dos medicamentos postulados e a inexistência de substituto terapêutico.** Além do mais, sequer foi acostado aos autos a negativa do fornecimento da Administração Pública, o que impede a análise de eventual ilegalidade do ato administrativo.*
*(**TJMS**. Apelação / Remessa Necessária n. 0802876-89.2023.8.12.0029, Naviraí, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Alexandre Corrêa Leite, j: 31/01/2025, p: 03/02/2025)*

Portanto, o papel do Poder Judiciário, em casos como o presente que buscam o fornecimento de medicamento pelo Poder Público não pode se desviar das diretrizes e da Política Pública de Medicamentos, sob pena de usurpar a competência do Poder Executivo e prejudicar não só a saúde da própria parte requerente, através da concessão do medicamento pedido segundo entendimento deste ou daquele médico, desconsiderando a existência de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas que estão baseados em evidências científicas, mas também todo o Sistema Público de Saúde que depende da regulação estatal para manter a atenção básica e avançada de saúde em todas as suas frentes.

Na hipótese, portanto, diante da ausência de demonstração nos autos de que a parte autora tenha feito uso de todos os fármacos padronizados e fornecidos pelo SUS e que este tenham sido ineficazes, inexistindo justificativa médica plausível para a utilização do tratamento pleiteado, em vez do fornecido pelo SUS, não comporta acolhimento o pedido.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 06/06/2025 às 08:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800476-28.2024.8.12.0010 e código XarZ4fG5.

Dispositivo:

Posto isso, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo **improcedente** o pedido e **revogo** a tutela de urgência de p. 36/41.

Condena-se a parte requerente no pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC. Entretanto, suspendo a exigibilidade da parte devida pela requerente, vez que goza dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

Intimem-se o Estado, a DPE e o MPE pelo SAJ, dando-se-lhes vista dos autos.

Certificado o trânsito em julgado, e não havendo modificação da presente decisão, arquivem-se os autos, com baixa.

Às providências.

Fátima do Sul, data da assinatura digital.

Vitor Dias Zampieri
Juiz de Direito
(assinado por certificação digital)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 06/06/2025 às 08:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 08000476-28.2024.8.12.0010 e código XarZ4fG5.